

06 - 06- Maladies inflammatoires de l'intestin Partie II - Pr. Krati

Bonjour, donc on va continuer par la deuxième partie des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et nous aborderons les aspects cliniques, biologiques, endoscopiques et histologiques de la rectocolite hémorragique. On va aborder aussi et parler de la démarche diagnostique, comment elle émet les autres diagnostics différentiels et nous terminerons par les principes thérapeutiques des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, la maladie de crâne et la rectocolite hémorragique. Pour la maladie hémorragique, son expression clinique peut comporter des signes généraux, des signes digestifs et des manifestations extra-digestives.

Concernant les signes généraux, on peut observer une altération de l'état général à type d'un amérissement. Celui-ci est plus important dans la maladie de crâne que dans la RCH. Le malade peut aussi présenter une asthémie.

Le malade peut avoir une fièvre. Sachez que la découverte d'une fièvre en cas de rectocolite hémorragique, c'est un signe d'alarme parce qu'il peut révéler soit une poussée sévère ou une forme compliquée. Il peut même faire craindre une coulisse grave ou une surinfection.

Les signes digestifs se résument dans des émissions hémorragiques, soit à type de rectoragie, soit à des émissions glaérosanglantes, du glaire mélangé à du sang. Les émissions glaérosanglantes, c'est un symptôme très fréquent. On peut parfois, dans les atteintes rectales, avoir des rectoragies de façon isolée et intermittente.

Mais sachez que le plus souvent, c'est des émissions glaérosanglantes qui sont souvent aphécales. Dans les rectites sévères, on peut avoir un syndrome rectal qui regroupe des épreintes, des ténèbres, des faux-besoins, d'impériorité et des rectoragies. La découverte d'un syndrome rectal complet témoigne de l'importance de l'atteinte rectale, donc de la rectite.

Et ce syndrome souvent altère la qualité de vie du patient. Dans les atteintes étendues de la RCH, on va carrément avoir une diarrhée. C'est une diarrhée qui est glaérosanglante.

On a des selles avec du glaire et du sang. La douleur abdominale se voit lorsqu'on a des atteintes couliques étendues. Ce sont souvent des douleurs en barres, hypogastriques, où il intéresse les deux fossiliacs, le plus souvent la fossiliaque gauche.

Ils peuvent être diffus dans les atteintes étendues du côlon, c'est-à-dire dans la pancrose. Concernant les manifestations extra-digestives, elles sont identiques à celles de la maladie et les plus fréquentes sont représentées par les atteintes articulaires. Il faut distinguer au niveau des atteintes articulaires les rhumatismes périphériques, qui sont un type d'arthragie ou carrément des arthritides inflammatoires, qui vont intéresser les grosses articulations le plus souvent, les articulations périphériques, les genoux, les coudes, les poignets, etc.

On peut avoir des rhumatismes axiaux, c'est-à-dire une teinte, soit une pelvis pendilique ou une

sacroïlique. Ces rhumatismes articulaires, contrairement aux rhumatismes périphériques, celui-ci évolue de façon indépendante de la teinte digestive. Il peut parfois précéder la teinte digestive.

C'est un patient qui va consulter chez le rhumatologue pour les manifestations articulaires axiales. C'est après que les manifestations digestives peuvent apparaître. Deuxièmement, ils peuvent survenir après, pendant ou en même temps que les manifestations digestives, ou à distance des manifestations digestives.

Ils vont évoluer de façon indépendante. Parfois, on arrive à contrôler la teinte digestive. Par contre, la teinte axiale nécessite une prise en charge spécifique.

Ceci est contraire au rhumatisme périphérique, qui évolue parallèlement au poussé digestif. Il ne nécessite pas de traitement spécifique. Lorsqu'on contrôle la teinte digestive, ces atteintes périphériques vont disparaître.

À côté des atteintes articulaires, il y a les atteintes cutanées. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est l'érythème nouveau. Il est plus fréquent dans la maladie de Crohn que dans l'ARCH, mais il peut se voir aussi dans l'ARCH.

On a le pyoderma gangréneux, les ARCH, les érythèmes, etc. On a aussi la teinte oculaire. C'est une manifestation qui est fréquente.

C'est une atteinte du segment antérieur de l'œil. Donc, il peut donner une épisclérite, un érythème ou une UVI. Il y a d'autres atteintes qui peuvent aussi se voir.

Les atteintes hépatiques comme une stéatose, une hépatite granulomateuse. Dans l'atteinte hépatique, il y a la cholangite sclérosante primitive qui se voit dans les maladies inflammatoires de l'intestin chronique. Mais il faut savoir qu'il est plus fréquent dans l'arctoculite hémorragique.

D'ailleurs, lorsqu'on découvre chez un patient une cholangite sclérosante primitive, parmi les examens à demander chez ce patient, c'est de faire une coloscopie à la recherche d'un arctoculite hémorragique qui est sain. Il y a aussi les atteintes rénales, soit des néphropathies, soit un syndrome néphrotique, des néphropathies prolifératives. Il y a aussi les atteintes hématologiques.

Donc, la liste est longue. Mais ce qu'il faut savoir, les plus fréquents, c'est les atteintes articulaires, cutanées et oculaires. Donc là, sur cette diapo, la première montre une arthrite du genou.

C'est une atteinte périphérique. Là, ce qu'on voit sur la deuxième photo, c'est plutôt une épisclérite. Donc, c'est un œil qui est rouge.

Là, c'est les lésions cutanées qu'on peut observer. Vous avez les ulcérations au niveau de la

gencive. Vous avez le pyoderma gangrenosum, qui est une large ulcération sans tendance à la cicatrisation.

Et vous avez les rites musulmanes, les nodules qui sont rouges au niveau des deux jambes. Là, on a des lésions pustuleuses. Là, vous avez une lésion nécrotique cutanée.

Donc, la richesse de lésions cutanées au cours de ces maladies inflammatoires, mais qui sont les plus caractéristiques et les plus évocatrices, reste le pyoderma gangrenosum, les rites musulmans. Concernant leur expression dans la clinique, sur le plan biologique, il faut chercher toujours un syndrome inflammatoire qui va se manifester par une élévation de la protéine c-réactive, par une hyperleucocytose à prédominance polynucléaire neutrophile et une thrombocytose. Ce syndrome inflammatoire n'est pas constant.

Il se voit surtout dans les poussées actives. On peut aussi avoir une anémie hypochrome microcytaire qui peut être inflammatoire avec une véritimémie élevée ou qui peut être liée à un saignement occulte ou au saignement aux diarrhées gluosanglantes d'origine ferropropre. Il faut demander un bilan hépatique parce que, comme nous avons vu, dans la rectocolite hémorragique comme dans la maladie de Crohn, on a parfois une atteinte hépatique.

Le bilan immunologique n'est pas obligatoire parce qu'il n'est pas spécifique. Il n'est pas spécifique et il est peu sensible. Mais parfois, lorsqu'on n'arrive pas à trancher entre maladie de Crohn et rectocolite hémorragique, il faut demander ce bilan parce que souvent dans la rectocolite hémorragique, on a les pancas, qui sont les anticorps anticytoplasmes des polynucléaires neutrophiles de localisation périnucléaire positive dans la rectocolite hémorragique, alors que les anticorps antisaccharomyces cérébritis sont négatifs.

Et dans la maladie de Crohn, on a le contraire. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas un bilan qui est demandé de façon systématique. Il faut le demander s'il y a un problème de diagnostic différentiel entre les deux maladies.

Il faut toujours faire un bilan infectieux pour faire le diagnostic différentiel parce que les colites infectieuses peuvent donner le même tableau clinique qu'une rectocolite hémorragique. Deuxièmement, au cours de la rectocolite hémorragique, on peut avoir une surinfection. C'est pour ça qu'il faut demander une coproparasitologie d'espèce.

Et il faut évaluer l'état nutritionnel à la recherche surtout d'une hypoalbuminémie, qui est un signe de gravité et qui traduit l'importance de l'entéropathie exudative liée aux lésions de la colite. L'endoscopie avec biopsie reste un examen très important dans la rectocolite hémorragique. On peut déjà démarrer par une rectosigmoidoscopie qui permet l'exploration du rectum et du sigmoïde en attendant la préparation du malade pour faire une héliocoloscopie.

Donc une exploration de tout le colon avec cathétérisme iléal. Pourquoi faire le cathétérisme iléal ? Pour éliminer une atteinte iléale qui se voit pour faire le diagnostic différentiel avec la maladie de

Crohn. Et bien sûr, il faut faire cet examen endoscopique doit être accompagné obligatoirement des biopsies étagées aussi bien au niveau de la muqueuse qui paraît pathologique que la muqueuse qui paraît non pathologique.

Cette endoscopie permet de faire le diagnostic différentiel. Déjà, il va montrer si on a un aspect de Crohn ou de RCH. Il peut aussi rechercher s'il y a un cancer qui est responsable de la maladie.

Donc il permet de voir l'aspect, trouver l'aspect caractéristique de la RCH et cartographier la présence d'éventuels cancers. Il permet aussi d'évaluer l'étendue des lésions parce qu'on peut avoir une atteinte qui est limitée au rectum, c'est la rectite. On peut avoir une atteinte qui est limitée au rectum sigmoïde, c'est la recto-sigmoïdite.

Et on peut avoir uniquement une atteinte du colon gauche. Donc c'est une atteinte gauche. Et lorsque cette atteinte dépasse l'angle colicoce, on dit que c'est une atteinte qui est étendue, que c'est une pancolite.

Et l'endoscopie permet aussi de trouver des lésions endoscopiques de gravité. Par exemple, des ulcérations creusantes, un pont, un décollement avec visibilité de la muqueuse témoignent de la profondeur de l'atteinte et c'est un signe de gravité. Et il faut rechercher, comme la rectocolite hémorragique, c'est une lésion, c'est une condition précancéreuse, donc il faut faire aussi les biopsies et rechercher des lésions en faveur de dysplasie ou d'une cancérisation.

Qu'est-ce qui nous permet d'évoquer une rectocolite hémorragique ? C'est une atteinte qui continue de la muqueuse et qui démarre au niveau des rectums. C'est une muqueuse qui va être inflammatoire, granité, épicée, hémorragique, qui scinde facilement au contact de l'endoscope avec des ulcérations de taille variable qui peuvent être superficielles ou profondes selon la gravité. Et ces lésions, bien sûr, ils démarrent au niveau des rectums, ils vont partir s'étendre sur le côlon sans intervalle de muqueuse.

Et lorsqu'on fait la coloscopie avec une myoscopie, on va voir qu'il y a une atteinte uniquement du côlon, sans atteinte de l'angle iléale. Et donc ça, c'est un aspect qui est très évocateur de la rectocolite hémorragique. Bien sûr, si on a une atteinte gauche uniquement, on aura l'atteinte qui va s'arrêter, les lésions, de façon brutale, au niveau du côlon gauche.

Et ça dépasse, donc on est dans l'atteinte étendue. Là, sur cette diapo, on voit une muqueuse qui est épaissie, donc on ne voit pas les vaisseaux, la visibilité est disparue, avec une muqueuse qui scintille, avec quelques ulcérations texturées, donc un aspect granité. Là, vous avez des ulcérations superficielles de quelques millimètres à plusieurs centimètres, avec des formes variables, et en cartes géographiques, qui confluent par endroits.

Sur cette diapo, on voit ces lésions, c'est des pseudopolypes, donc inflammatoires, c'est des lésions séculaires, donc après une poussée inflammatoire avec des ulcérations, la régression de

la poussée peut laisser en place ces lésions séculaires qui témoignent du caractère antérieur du début de la maladie. Sur le plan histologique, il n'existe pas de critères anatomopathologiques ou pathognomoniques spécifiques qui permettent de retenir le diagnostic, mais il existe des aspects évocateurs qui peuvent, en les regroupant avec les signes endoscopiques, avec le profil clinique, avec le profil évolutif, on peut donc dire que c'est des éléments en faveur du diagnostic de la rectocolite hémorragique. Ils sont d'abord représentés par l'inflammation qui est superficielle, limitée à la muqueuse et à la sommiqueuse, par une atteinte de l'architecture des cryptes qui sont désorganisées, par la présence de nombreux abcès cryptiques et par un infiltrat inflammatoire, l'infoplasmositaire du corneau.

Au cours de la rectocolite hémorragique, on ne trouvera jamais de granulones hypothéologiques autocellulaires qui permettent de faire le diagnostic différentiel avec la maladie de Crohn. Concernant les explorations morphologiques, leur place dans la maladie de la rectocolite hémorragique est limitée. Ils ont un intérêt surtout dans les formes compliquées ou dans les formes sévères pour rechercher des complications, notamment rechercher la colectasie ou la perforation colique.

Il y a l'abdomen sans préparation qui permet de rechercher la colectasie en montrant un diamètre supérieur à 5 cm au niveau du colon gauche ou un diamètre supérieur à 7 cm concernant le colon transverse et le colon droit avec une disparition des oustracences et des signes de la colectasie. Il peut aussi être réalisé en cas de suspicion de perforation en montrant le pneumo-péritoine. Concernant le lavement barité en double contraste, cet examen a été détrôné par l'endoscopie.

Son indication est de moins en moins proposée. On peut le demander chez des patients qui ont des ténons pour caractériser les ténons. S'il est fait, il peut montrer un aspect en faveur de la rectocolite hémorragique, par exemple un aspect granité, ce qu'on va rechercher au niveau de la paroi du colon, surtout dans les phases inflammatoires, congestives.

On peut aussi trouver un aspect reticulé qui traduit des ulcérations qui vont être comblées par la barique. Il peut aussi montrer un aspect tubulé, perte des oustracions du colon. Cela témoigne d'une maladie chronique ancienne.

L'échographie abdominale a un intérêt au niveau de la rectocolite hémorragique pour les maladies inflammatoires. Elle va montrer l'épicissement parital surconférentiel de la paroi digestive. L'échographie simple ne permet pas de distinguer les couches ni de les caractériser.

Mais actuellement, grâce à de nouvelles techniques, on peut même étudier le caractère inflammatoire au nom de l'épicisme. Le scanner a un intérêt surtout pour voir les complications, la perforation en particulier. Mais il faut savoir qu'il peut aussi montrer des signes en faveur de la rectocolite hémorragique, l'aspect tubulé, la stratification paritale qui traduit l'inflammation avec la paroi qui va être rehaussée, surtout la musculuse.

Mais ce sont des lésions qui ne sont pas spécifiques. Il garde sa place surtout pour le dépistage des complications. Sur ces images-là, sur la première, on a un aspect de colectase.

On voit qu'il y a de la colectase qu'il faut mesurer. Sur la celle de droite, on a l'aspect tubulé. On ne voit plus l'illustration du colon avec un aspect grinté au niveau de la paroi.

Sur la troisième, ça c'est un scanner. Il permet de montrer l'épicissement de la paroi colique au niveau du sigmoïde avec toujours l'aspect tubulé. Sur la quatrième image, on a une colongeographie.

En fait, il montre un aspect de colongite sclérosante, manifestation hépatique extra-digitif de la rectocolite hémorragique. Comment poser le diagnostic de la rectocolite hémorragique ? En fait, il n'y a pas un signe pathognomonique spécifique qui permet de dire que ce patient a une rectocolite hémorragique. Mais le diagnostic repose sur un faisceau d'arguments cliniques, épidémiologiques, endoscopiques, histologiques.

Et bien sûr, en éliminant toutes les autres pathologies qui peuvent donner la même symptomatologie, notamment le cancer colique. Donc les données épidémiologiques et cliniques, elles sont surtout représentées par l'âge. Le sujet général, il faut toujours penser à ces maladies inflammatoires.

Chez un patient qui a des antécédents familiaux demi-quiens, que ce soit le RCH lecrans, c'est un élément qui est en faveur de la maladie, en faveur de la rectocolite hémorragique. Les antécédents aussi personnels du patient, si le patient présente des antécédents de maladies disséminées ou des manifestations articulaires, donc il faut penser à ces maladies inflammatoires. Il faut aussi rechercher des critères en faveur, par exemple les circonstances déclenchantes pour la rectocolite hémorragique.

Il faut rechercher une notion de sevrage ou une infection traitée par antibiothérapie ou quelque chose qui peut être à l'origine de la décompensation et l'apparition de la maladie. Les signes digestifs, donc devant toute diarrhée gluosanglante ou devant toute rectocolite, devant tout syndrome rectal chez un sujet général, il faut penser à ces maladies inflammatoires. Il faut aussi penser, lorsqu'on a des manifestations digestives associées à des manifestations extra-digestives, là aussi c'est un critère qui est en faveur des maladies inflammatoires.

À côté des critères épidémiologiques et cliniques, il y a les critères endoscopiques qui reposent sur l'atteinte continue, homogène, d'un seul tenant sans intervalle de muqueuse saine depuis le rectum et qui s'étend sur le colon. C'est un élément qui est très évocateur de la maladie de la rectocolite hémorragique. Et bien sûr, ce critère va être renforcé aussi lorsque les histologies donnent un aspect évocateur qui est représenté par une atteinte superficielle de la paroi, donc une atteinte qui domine sur la muqueuse et la sous-muqueuse, avec un infiltrant inflammatoire lymphoplasmositaire du colon, avec une désorganisation glandulaire et anomalie de la mycose

crescent et des abcès cryptiques.

Ce sont des éléments histologiques aussi en faveur. Et bien sûr, chez un patient jeune avec une symptomatologie évocatrice avec un aspect endoscopique et histologique évocateur, il faut penser aux maladies à la rectocolite hémorragique, mais il faut toujours éliminer d'abord une colite infectieuse, parasitaire, médicamenteuse et ischémique et un cancer. Donc, grâce à l'endoscopie, la colonoscopie totale, mais aussi à la réalisation des coproparasitologies de sel, à rechercher une crise médicamenteuse ou un terrain de maladies ischémiques, notamment un vascularite ou une maladie embolivée.

Donc, quels sont les diagnostics différentiels que nous devons éliminer ? En fait, les causes infectieuses et parasitaires peuvent donner un tableau clinique qui ressemble à celui de la rectocolite hémorragique, notamment l'infection à *pompiobactères*, les salmonelloses, les tchigelloses. Tous les colobacilles entéroinvasifs peuvent être annoncés à l'origine d'une inflammation de la mycose avec des oxidations. Mais là, c'est l'histologie, la coproparasitologie et le terrain, aussi les aspects endoscopiques.

Il y a aussi le *cherichia coli*, mais généralement, ça donne une colite hémorragique avec parfois des ulcérations. Et dans ce cas, on va trouver les toxines dans les sels qui permettent de redresser le diagnostic. Il y a aussi le *klebsiella oxytoca* qui donne aussi une colite hémorragique avec des ulcérations.

Mais généralement, sur le plan endoscopique, le rectum n'est pas atteint. On trouve au niveau de l'interrogatoire la notion de prise d'antibiotiques et la culture de la biopsie va isoler les germes. Dans tous les cas, chez cette patiente, l'arrêt de l'antibiothérapie permet la régression de la maladie.

Il y a aussi le *clostridium difficile* qui peut être responsable d'une colite ulcérepsidomembraneuse qui peut être même parfois hémorragique. Et là aussi, on a la notion de prise médicamenteuse et la coupe parasitaire avec recherche de toxines de *clostridium difficile*, AFP, permettra le diagnostic. Il y a aussi les maladies sexuellement transmissibles qui peuvent être responsables de rectites comme la rectite agonocore, le *treponoma pallidum*, le *chlamydia*, l'herpès, le virus.

Souvent, on trouve un terrain particulier, soit des homosexualités ou des partenaires multiples, donc un terrain à risque. Généralement, le tableau, par exemple, pour la rectite agonocore, ça donne des ulcérations avec des sécrétions. Ce n'est pas homogène et généralement, l'étude des lésions qui vont régresser après le traitement antibiotique.

Il y a la folie de la cytomegalovirus qu'on voit chez le sujet VIH positif, immunodéprimé, qui peut donner aussi des ulcérations, mais là aussi, ça va montrer des inclusions aux cytomegalovirus. Il y a la tuberculose colique, mais généralement, pour la tuberculose colique, la localisation colique de la tuberculose n'est pas exceptionnelle. Généralement, c'est une atteinte qui est segmentaire.

Il peut aussi donner des ulcérations, des pseudopôles, des sténoses, mais il faut savoir que, le plus souvent, c'est une atteinte qui domine au niveau du sécum plus qu'au niveau du côlon. Les biopsies vont montrer le granulome, l'hépatite, la recherche de BK par PCR sur le prélèvement peut aussi mettre en évidence le bacille de corps. On a la myiase colique, qui, en général, c'est une atteinte segmentaire, qui peut donner des ulcérations à l'emporte-pied, soit aponib.

Il peut parfois même être responsable de sténose. Et ce qu'il faut savoir dans la myiase colique, c'est qu'elle aussi peut être chronique, c'est maltraité, mais le plus souvent, dans la rectocolite hémorragique, on peut avoir une surinfection par la myiase. D'ailleurs, si on connaît le patient qui est porteur de la rectocolite hémorragique, ça ne pose pas de problème, on sait que c'est une surinfection.

Mais le problème, il se pose lors de la première poussée de RCH, quand on découvre des amibes au niveau de la coproparasite et aussi au niveau du prélèvement histologique. Et là, la question, est-ce qu'il s'agit d'une surinfection amibienne ou est-ce qu'il s'agit d'une rectocolite hémorragique surinfectée ? Donc, c'est l'évolution de la maladie qui va permettre de trancher. Il y a aussi certains parasites comme le schistosomiasme, stranguloïdes, stercorales, qui peuvent donner aussi des colites, mais là aussi, la coproparasite permet de trancher.

D'autres étiologies aussi de rectocolite, comme les saignements hémorragiques, dans les saignements hémorragiques, la colonoscopie va montrer les hémorragiques avec une atteinte, sans atteinte, pardon, du rectum et du côlon. Une diagnostic différentielle est facilement faite. Il y a aussi certains médicaments qui peuvent être à l'origine des ulcérations, comme les vasoconstricteurs, à savoir les médicaments qui contiennent de l'érotamine, les digitaliques.

Il y a aussi les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui sont souvent responsables des ulcérations intestinales ou particuliers coliques, en particulier lorsqu'ils sont pris parfois sous forme de suppositoires. On a les phénotiazines, le méthotrexate, les pénicillamines, l'aspirine, l'alpha-méthyl-2-pas, mais généralement c'est des ulcérations, ce n'est pas une atteinte d'un seul moment et l'interrogatoire permet d'évoquer le diagnostic. Il y a les coliques toxiques chez les patients qui se droguent à la cocaïne et on a les coliques chimiques comme par l'acide acide.

Certaines maladies ou certains vascularites peuvent être à l'origine, comme la maladie, comme tous les vascularites, peuvent être à l'origine des ulcérations, mais sur l'histologie, il y a le terrain, le contexte qui est en faveur de ces maladies et les biopsies qui vont montrer des lésions en faveur des vascularites. Il y a l'histoire du fil, là aussi l'histologie permet le diagnostic. Il y a les coliques neuropathiques qu'on voit souvent chez les patients sous chimiothérapie, là aussi c'est le contexte.

Et bien sûr, l'aspect n'est pas identique. Il y a les récits post-radicaux qui peuvent être responsables d'un aspect hémorragique, mais là aussi, le contexte est très évocateur. Comment évaluer la gravité de la maladie ? En fait, on a ce qu'on appelle le score de Triolov et Witts

modifié, qui est basé sur le nombre de selles, la température, le rythme cardiaque, l'hémoglobine et la vitesse de sédimentation.

Donc, on parle de poussée sévère lorsque le nombre de selles sanglantes est supérieur à 6, lorsqu'il existe une température supérieure à 37,5, lorsque le malade est tachycarde, lorsqu'il présente une anémie ou lorsqu'il a une inflammation avec une vitesse de sédimentation qui est supérieure à 30. Ces critères simples et faciles à évaluer permettent rapidement d'identifier la poussée sévère qui nécessite une prise en charge spéciale et en urgence. Bien sûr, il y a d'autres critères qui ne font pas partie de cette classification parce que c'est aussi important.

C'est la protéine c-réactive. Une protéine c-réactive élevée, c'est un élément de mauvais pronostic. C'est la présence d'une hypoalbuminémie qui traduit une antéropathie qui est d'une importance.

Ce qui traduit l'importance des lésions. Quand est-ce qu'on va parler d'une coulisse grave ? Lorsqu'il y a des signes généraux chez un patient qui est fébrile, altéré, et avec un nombre de selles qui est très élevé, un triologie sévère. Il faut dire que chez ces patients-là, la présence de certains cils endoscopiques montre que la coulisse est grave.

Notamment si on trouve des ulcérations profondes et larges ou des ulcérations en pluie avec des décollements muqueux responsables d'une perte de substance mettant à nu la musculature. Là, c'est des lésions endoscopiques de gravité. Elles traduisent un risque élevé de complications comme la colectasie, l'hémorragie digestive massive et la perforation intestinale.

C'est une urgence thérapeutique qu'il faut rapidement hospitaliser en soins intensifs et démarrer le traitement spécifique. L'évolution de la maladie, la rectocolite hémorragique peut évoluer de façon chronique avec des poussées entrecoupées de phases de rémission. Ces phases de rémission peuvent être prolongées, comme elles peuvent être courtes.

On peut parler même d'une évolution suble. De toute façon, lorsque le malade est repoussé, il est exposé à développer un certain nombre de complications. La colectasie aiguë avec un risque de perforation est celle-ci et c'est une urgence aussi thérapeutique.

Il faut savoir que pour éviter les colectasies, si les patients ont poussé, il faut éviter de donner les anticholinergiques, les antidiarrhéiques, les ipocalcines, parce qu'ils augmentent le risque de la colectasie et l'exposent au risque de perforation. Attention, la colectasie et la perforation peuvent être masquées chez ces patients parce qu'ils sont souvent sous corticoïdes et donc ils peuvent faire une perforation aseptique sans avoir la contracture douloureuse, cette raideur de l'abdomen. C'est pour ça que chez ces patients, il faut les surveiller de façon quotidienne, clinique et biologique.

Ce sont des malades qui doivent être hospitalisés au milieu de réanimation et au moindre doute de perforation ou de phase très perforative pour poser le malade pour la chirurgie. Il y a aussi

l'hémorragie importante, incontrôlable, qui peut parfois être une indication à la chirurgie. Il y a les complications, les sténoses, qui sont plus rares que dans la rectocolite hémorragique.

Ce sont des sténoses qui sont fibreuses, ils doivent toujours rechercher un cancer parce que le risque de dégénérescence est important. Généralement, c'est des sténoses qui sont courtes et qui surviennent chez des patients qui ont une atteinte étendue, pancréotique et qui ouvrent depuis longtemps. Ces sténoses peuvent être asymptomatiques et peuvent parfois être responsables d'un syndrome occlusif ou subocclusif ou d'un syndrome de cumul.

Le cancer colorectal, c'est une complication aussi bien de la rectocolite hémorragique que de la maladie de Crohn. Il faut savoir que ce risque est important, d'autant plus que la maladie a évolué à un âge très jeune, que le patient a, dans ses antécédents familiaux, un cancer colorectal ou lorsqu'il y a une association avec la colangite primitive. Le cancer peut être en forme sténosante, polypoïde ou infiltrant.

C'est pour ça qu'il faut savoir rechercher d'abord le prévenir par un traitement correct de la poussée et discuter chez les patients les 5 hasards qui peuvent être proposés comme un traitement préventif et faire des coloscopies, des dépistages avec coloration pour dépister les dysplasies avant l'installation du cancer. On ne va pas parler de traitement proprement dit, mais on va parler uniquement des principes du traitement dans ces médecins-là. D'abord, les moyens médicaux, on a les anti-inflammatoires utilisés, c'est les dérivés 5 aminosalicylés qui sont représentés par la sulfasalazopéridine, les salicylés de deuxième génération, c'est la mesalazine qui est représentée par le pentasa ou salcrozine.

Il y a d'autres non commercialisés qui ne sont pas commercialisés au Maroc. Il faut savoir que la mesalazine peut exister soit en suppo, soit en comprimé, soit en lavement, comme un traitement local ou par voie générale. La mesalazine, c'est deux molécules de 5 azas qui sont reliées par un groupe.

Il y a aussi l'olsalazine qui est aussi d'un 5 azas, c'est une molécule de 5 azas qui est englobée, c'est ce qu'on a commercialisé sur un nombre important. Donc ça, c'est les salicylés de deuxième génération. Ensuite, on a les corticoïdes.

Les corticoïdes, là, ils existent sous forme de comprimé, sous forme d'ampoule pour usage intraveineux. Et on peut faire des lavements pour un traitement local. Il y a les corticoïdes, là c'est les corticoïdes, donc de façon globale, il y a certains corticoïdes qui ont une action topique locale au niveau de l'intestin.

Ils sont représentés par le budesonide. Donc il y a une place, un intérêt dans la maladie de Crohn à localisation iléale ou iléoéciale. Là, ils montrent leur efficacité.

Deuxième, après les anti-inflammatoires, il y a les immunosuppresseurs qui sont représentés par l'azathioprine. Le commercialisé, c'est le nom du mercaptopurine. Ils sont donnés à la dose de 2,5 à 3 mg

par kg par jour.

On a les susmercatopérines, c'est un dérivé de l'azacioprine, qui est donné à la dose de 1,5 mg par jour. On a le méthotrexate qui est donné en général par voie intramusculaire ou subcutanée. On a la cyclosporine.

Et plus récemment, on utilise la biothérapie. Les biothérapies qui sont utilisées dans la maladie de crône et la FCA, c'est les anti-TNF, représentés par l'infleximab, commercialisés soit sous le nom de Remicade ou Remcimab. On a aussi la dalimab, c'est un deuxième anti-TNF, qui est commercialisé au Maroc sous le nom de Humera.

On a les anti- intégrines, qui n'est pas commercialisé au Maroc. On a les interleuquines 12 et 13. Les anti-interleuquines 12 et 13, c'est l'estucunumab, qui est commercialisé au Maroc sous le nom de Steller.

On a aussi les antibiotiques. Les antibiotiques qu'on utilise, c'est le metronidazole et l'aciprofloxacine. On a les anticoagulants à bas poids moléculaire, comme l'héparine, qu'on donne dans les formes sévères pour éviter et prévenir la survenue de de thrombose, parce que les maladies inflammatoires sont des maladies thrombogéniques.

Pour la chirurgie, en fait, la chirurgie, elle est indiquée essentiellement dans la maladie, dans la rectoculter hémorragique, et puisque dans la myocrone et dans la rectoculter hémorragique, peut-être, c'est un traitement qui peut être curatif, contrairement à la myocrone. Donc, on peut proposer la colectomie en conservant le rectum, en faisant une anastomose iliorectale, soit on peut faire une coloprotectomie, et dans la coloprotectomie, on enlève tout le côlon avec le rectum et on fait une anastomose ilioanal avec un réservoir ilial en J qui est, donc, ça permet donc d'enlever tout le côlon avec le rectum. La différence entre les deux, c'est que dans la colectomie avec anastomose iliorectale, on peut conserver le rectum, ce qui doit justifier donc une surveillance régulière du rectum parce qu'il peut faire des poussées au niveau du rectum, il peut faire aussi des dégénération au niveau du rectum.

Par contre, dans la proctocolectomie, on n'a pas ce risque, mais le problème, c'est que le réservoir peut s'insurinfester, il peut s'inflammer, donner une pochite qui peut parfois être difficile à gérer. Donc, les choix entre la colectomie et la proctocolectomie doivent se faire dans un staff avec une décision qui est adaptée à chaque patient. Chez les patients, par exemple, qui ont un rectum malade, on est obligé d'aller faire la colectomie.

Par contre, si on a un rectum qui est contrôlé médicalement, là, on peut discuter la colectomie sur le tas. Et ça, dans la RCH, par contre, dans la médecrone, il est préférable, si on a un rectum qui n'est pas atteint, de proposer la colectomie au lieu de la proctocolectomie qu'il faut éviter en général dans l'analyse de Crohn. Il y a une deuxième chose pour la proctocolectomie.

Le risque de stérilité, il est faible, il n'est exceptionnel, mais il existe. Donc, il faut aussi discuter

avec le patient. Aussi, dans les traitements chirurgicaux, en particulier dans la maladie de Crohn, il faut savoir drainer les abcès, mettre à plat les fistules quand elles sont superficielles et proposer, parfois, chez les patients, dans les atteintes luminales, par exemple, sténosantes, fibrosantes, on peut proposer des réssections qui doivent être limitées.

Il y a une chose aussi dans les formes, par exemple, dans les maladies de Crohn résistantes localisées, là aussi, on peut des réfractaires aux traitements médicaux, on peut proposer parfois la chirurgie. Mais la chirurgie dans la maladie de Crohn doit être une chirurgie conservatrice et doit être bien discutée parce qu'après la chirurgie, il y a un risque de récurrence et si on enlève, on fait multiples réssections sur le grêle, on expose le malade à un grêle court qui est incompatible avec une vie normale, une qualité de vie correcte. Donc, pour les indications, d'abord il faut savoir qu'on a dans les maladies inflammatoires, comme c'est des maladies chroniques et voulues par poussée ou coupée de phase de rémission, il faut discuter le traitement de la poussée qui permet d'induire la rémission.

Une fois cette poussée, cette rémission induite, il faut penser à un traitement d'entretien pour éviter la rechute. Et bien sûr, il y a le traitement spécifique des complications qui peuvent engager aussi bien le pronostic vital que parfois fonctionnel. Comment surveiller ces malades ? D'abord, il faut surveiller l'efficacité, il faut surveiller les effets indésirables des traitements, surtout les traitements d'entretien qui sont donnés au long cours.

Il faut soutenir ces patients parce qu'avec les traitements, les poussées s'authentiquent sur la qualité de vie. Un soutien psychologique est indispensable. Il faut savoir dépister les dysplasies et les cancers.

Comment on va dépister ces dysplasies ou les cancers ? Par la surveillance endoscopique. D'ailleurs, une endoscopie doit être réalisée chez un patient dont la maladie évolue plus de 8 ans lorsqu'il a une pancolite et chez les malades qui ont une atteinte gauche à partir de 15 ans. Le rythme, si on a le rythme de surveillance pour les maladies qui évoluent depuis 10 à 20 ans, il faut faire une surveillance tous les 3 ans.

Pour les gens dont la maladie évolue de plus de 20 à 30 ans, c'est tous les 2 ans. Et lorsqu'elle est supérieure à 30 ans, c'est tous les ans. Bien sûr, il faut faire ces endoscopies en phase de rémission pour pouvoir voir les lésions, les anomalies liées à la dysplasie.

Il faut faire des biopsies, 2 à 4 biopsies tous les 10 cm et sur toutes les ondes suspectes, que ce soit surélevées, sténosées ou ulcérées. Et il faut utiliser les colorations pour pouvoir mettre en évidence ces dysplasies. La dysplasie de haut grade nécessite donc de justifier la colectomie.

La dysplasie de bas grade doit être donc recontrôlée, confirmée et là aussi, c'est une indication à faire la colectomie. Donc, en conclusion, les maladies inflammatoires de l'intestin chronique, malgré que leur étiopathogénie reste mal connue, c'est des maladies dont la physiopathologie est multifactorielle. Leur diagnostic repose sur un faisceau d'argument essentiellement clinique,

endoscopique et histologique.

Il faut savoir identifier rapidement les formes graves et poussées graves qui peuvent engager le pronostic vital et leur prise en charge et les multidisciplinaires entre les gastroenterologues, les chirurgiens, les radiologues et parfois les réanimateurs. Leur prise en charge a largement bénéficié de progrès réalisés en thérapeutique, notamment la biothérapie. Et attention, ces maladies augmentent le risque de cancérisation, donc c'est des patients qui doivent être surveillés.